# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 95461
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 24-10-2024

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : RAMIRO ANTONIO MU►OZ MOLINA | | | RUN | : 7.350.718-9 |
| F.Nac | : 11-09-1951 | Edad | : 73 AÑOS, 1 MES | Género | : Masculino |
| Dirección | : LLANQUIHUE 506 L DE CHILE | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : FONASA B | Teléfono | : 79285952 | | |
| Fecha Ingreso | : 2024-10-15 | Fecha Egreso | : 24-10-2024 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E14.0-DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA CON COMA DIABETICA

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) SHH resuelto
2) HTA
3) ACV secuelado
4) Epilepsia
5) Amputación supracondilea bilateral
6) HiperNatremia corregida
7) AKI en vías de resolución

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R73.9-HIPERGLICEMIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente traído por cuidadora por presentar cuadro clínico de compromiso del estado general, orinas turnias y con mal olor, desorientación y alteración del estado de conciencia
( somnolencia). Tratamiento para DM suspendido hace un par de meses, Tratamiento ambulatorio reciente con Nitrofurantoina por ITU
Cumpliendo criterios de SHH, es presentado a UPC quien desestima ingreso y sugiere manejo en sala
En sala ingresa en condiciones clínicas regulares, evoluciona favorablemente con buena tolerancia a la realimentación se mantiene disglicemico, con CSB + K. Pneumoniae, se procede a inicio de terapia ATB ertapenem/cotrimoxazol, actualmente en su dia N° 3 de tratamiento ATB, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

## PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventialtorio: estable, sin conflicto
3) Infeccioso/respiratorio: Actualmente cursando con cuadro de neumnia 2° a K Pneumoniae, en terapia ATB se completaran 7 dias de terapia en total, examenes de control para dia 28/10
4) Fonoaudiologico: Cursando con Tr deglutorio severo, se continuara alimentaciona a traves de SNG, evaluar isntalacion de GGT a traves de HODOM (se deja IC)

## INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM
2. Movilizar en cama cada 4hrs
3. ERTAPENEM 1 GR. AMPOLLA UNIDAD 1 ampolla cada 24 hrs. por 7 días via ENDOVENOSA

4. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
6. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. INSULINA N.P.H. 100 U.I. / 1 ML FRASCO 10 MINILITROS 1 frasco cada 48 hrs. por 1 dias via SUBCUTANEA
8. COTRIMOXAZOL COMPRIMIDO 800 MILÍGRAMOS / 160 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 7 dias via ORAL
9. HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
10. EXAMENES DE LAB CONTROL 28/10
11. PENDIENTE IC A ENDOSOCPIA PARA EVALUAR INSTALACION DE GGT

## EXÁMENES Y RESULTADOS

Creat 1.80 ELP 142/3.70/113
CSB : K. Pneumoniae
Hemocultivos negativos

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO